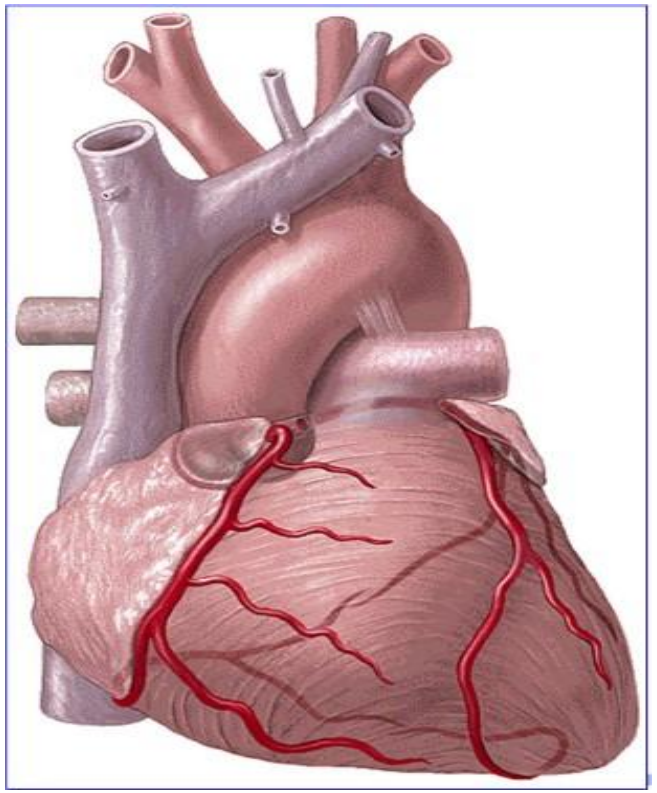


« Examen Cardiaque »

« 3 -ème Année de Médecine /Module de Sémiologie Médicale »

Dr K RIACHE/MEDECINE INTERNE/HMRUO

15/10/2023

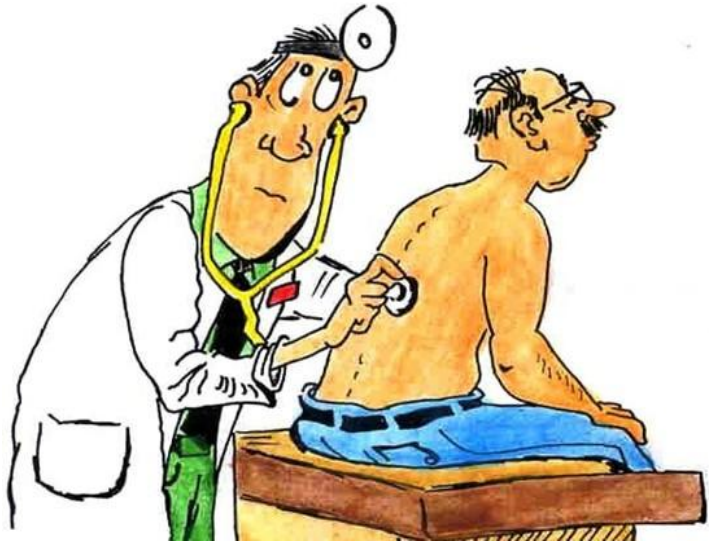
« Introduction »

La Sémiologie est une discipline qui etudie les signes :

- **les Signes Fonctionnels:** Plaintes formulées par les patients.
- **et les Signes Physiques:** Retrouvés lors de l'examen clinique.



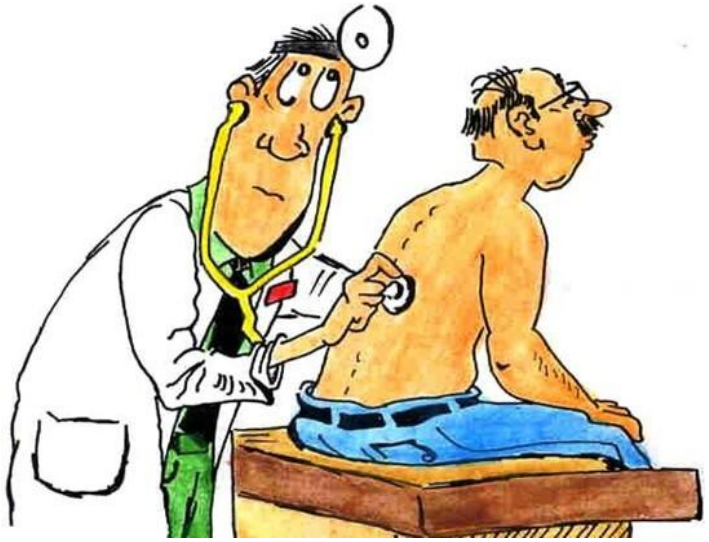




« Introduction »

❖ La prise en charge médicale impose de recueillir **les Antécédents Médicaux Personnels et Familiaux** du patient.

- de rechercher **les « Facteurs » de Risque** prédisposant **aux Affections Cardiaques** les plus fréquentes, de rechercher les signes d'éventuelles maladies.



« Conditions Pour L'examen Cardiaque »

- **Les instruments** : Stéthoscope, lampe, abaisse-langue, Montre, gants, tensiomètre, mètre ruban.

- L'examen clinique doit être faitdans une pièce calme à une température confortable.

- l'examen clinique comporte:

✔ **l'interrogatoire.**

✔ **L'inspection.**

✔ **La palpation.**

✔ **La percussion.**

✔ **et l'auscultation.**



« Conditions Pour L’examen Cardiaque »

- Examen se fait :

✔ Position Décubitus Dorsal,

✔ Décubitus Latéral Gauche,

✔ Assise penchée en avant,

✔ Debout Respiration Normale,

✔ Apnée Respiratoire et en Fin d’expiration ».



- L’INTERROGATOIRE :

Le medecin qui ne peut se livrer à un bon interrogatoire et le patient qui ne peut fournir les elements courent un peril commun :

Celui de donner ou de recevoir une mauvaise therapeutique (P.D.WHITE 1955)

« Interrogatoire du patient »

- Temps **essentiel** de

  l'examen clinique,

  indispensable à

l'établissement d'un diagnostic

- l'interrogatoire permet :

✔ De déterminer le **Motif de Consultation**.

✔ De recueillir **les Antécédents** et **le Mode de vie.**

✔ D'établir **l'Histoire de la Maladie**.



Pas cool



Cool

« Interrogatoire du patient »

« Antécédents Personnels et Familiaux »

- **Antécédents Personnels:** en trois parties :
  - **les Antécédents** Cardiovasculaires.
  - **les Antécédents** Médicaux.
  - **les Antécédents** Chirurgicaux.
- **et de préciser** les Hospitalisations Antérieures.



« les Antécédents Cardiovasculaires »

- les Coronaropathies et Antécédents d'infarctus du myocarde.
- les Valvulopathies.
- les épisodes d'insuffisance cardiaque.
- les Troubles de la Conduction.
- les Troubles du Rythme.
- les épisodes de Thrombose Veineuse Profonde et/ou d‘Embolie Pulmonaire.
- la présence de Pathologie Vasculaire « l'artériopathie oblitérante des membres inférieurs (AOMI).
- les autres Cardiopathies.

❖ **Les autres Antécédents Médicaux et Chirurgicaux.**

« Antécédents Familiaux »

- Tous les antécédents familiaux sont recherchés, particulièrement ceux de

Maladies Cardiovasculaires Athéromateuses.

✔ L’artériopathie Oblitérante des Membres.

✔ La Coronaropathie.

✔ L’Accident ischémique Cérébral.

✔ **Précoces** (moins de **55 ans pour l’homme**, **65 ans pour la femme**).

✔ chez des parents du premier degré **(père, mère, frère, sœur).**

Facteurs de risque cardio vasculaire :

On appelle facteur de risque toutecaracteristique anomalie ou habitude associé à un surcroit de developper la maladie , avec une relation jugée causale entre le risque et la maladie

« Facteurs de Risque Cardio-vasculaires »

- **L'âge** supérieur à **50 ans** chez l'homme et **60 ans** chez la femme.
- Le sexe **masculin**.
- **L'Hypertension Artérielle.**
- **Le Diabète.**
- **Le Tabagisme** avec l'âge de début, l'âge de fin, le nombre de paquets-années ainsi qu'un sevrage **inférieur à trois ans.**
- **La dyslipidémie**, le traitement pris.
- **L'hérédité cardiovasculaire :** infarctus du myocarde ou mort subite avant l'âge de 55 ans chez le père ou un parent du premier degré de sexe masculin ; ou infarctus du myocarde ou mort subite avant l'âge de 65 ans chez la mère ou un parent du premier degré de sexe féminin.
- **L'obésité :** IMC > 30 kg/m2 (surpoids : IMC > 25kg /m2).
- **La sédentarité.**

« Principaux Signes Fonctionnels Cardiaques 01 »

- **Les Symptômes Fonctionnels Cardiaques** les plus Fréquents sont :

✔ **Les *Douleurs Thoraciques.***

✔ **La *Dyspnée.***

✔ **Les Pertes de Connaissance : les *Lipothymies, Syncopes.***

- Il faut également rechercher la présence **d'une *Toux*** et **d'épisodes d'*Hémoptysie*.**

« les *Douleurs Thoraciques* »

✔ **les Douleurs Thoraciques** sont étudiées en détail dans le « Cours les Douleurs Thoraciques ».

- **Caractéristiques Des Douleurs Thoraciques :**

✔ Circonstances d'apparition.

✔ Siège.

✔ Type Facteurs aggravants.

✔ Facteurs apaisants.

✔ Irradiation / migration , Durée.

✔ Fréquence de survenue.

✔ Signes associés.

« la *Dyspnée* »

- C’est la ***perception consciente d’une gêne respiratoire*** , une sensation de manque d’air avec essoufflement.
- étudiée en détail dans le Cours « les Dyspnée ».

« les Palpitations, les Malaises »

- C’est la ***perception anormale et déplaisante des battements cardiaques*** ressentis plus forts et/ou plus rapides, anormalement puissants.
- étudiés en détail dans le Cours « les *Palpitations* ».

« Les Pertes de Connaissance : les *Lipothymies, Syncopes* »

- La ***Syncope*** est une perte de connaissance **<u>subite</u>** de **<u>brève durée</u>** due à une baisse transitoire du débit sanguin cérébral.
- La ***Lipothymie*** est un malaise sans réelle perte de connaissance.
- étudiée en détail dans le Cours « les Syncopes ».

« Examen du Patient : Recueil des Signes Physiques »

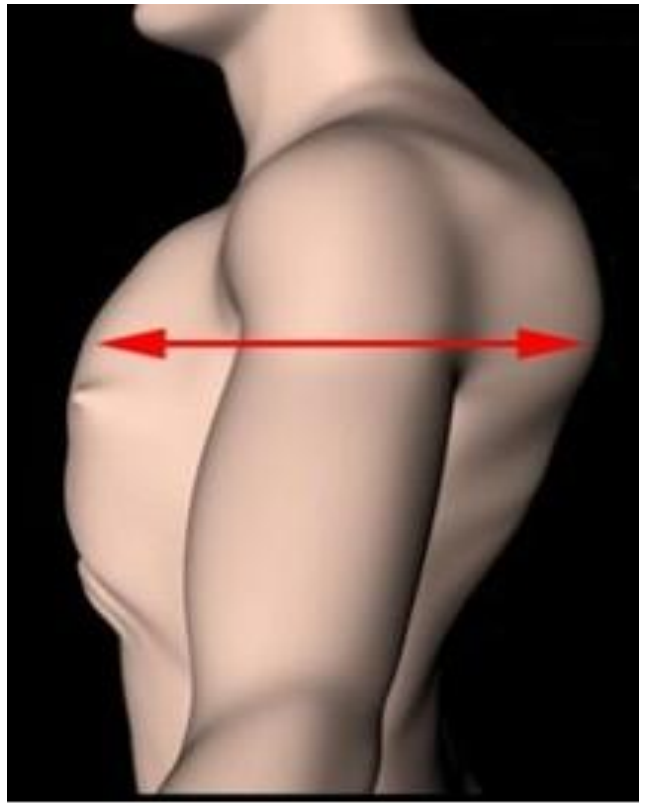
« Inspection »

- Chez **le Sujet Normal**, l'examen de la Région précordiale ne montre rien.

- L'inspection du thorax peut **occasionnellement** fournir des informations utiles :

Morphologie : thorax «en tonneau»

des insuffisants respiratoires.

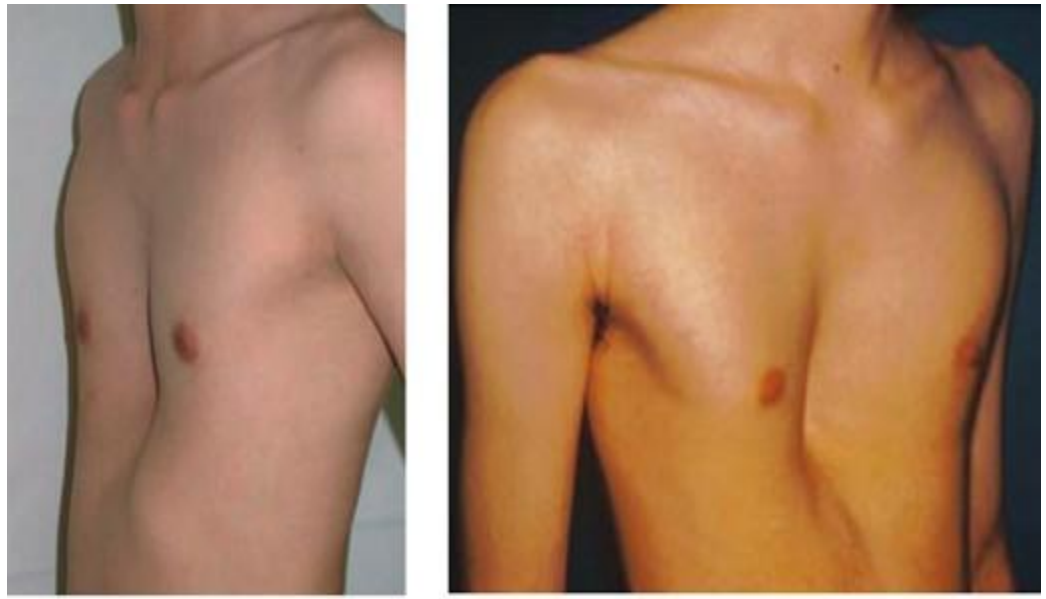


thorax en tonneau

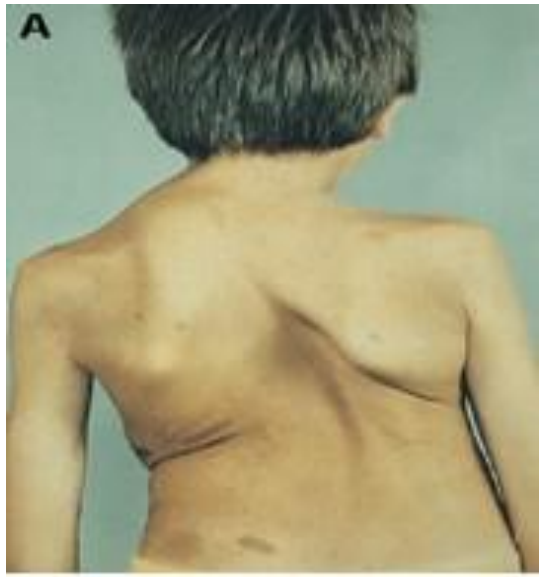
« Examen du Patient : Recueil des Signes Physiques »

« Inspection »

- **Morphologie : thorax « en entonnoir »** (*pectus excavatum*), cypho-scoliose…



thorax en entonnoir



cyphoscoliose.

« Examen du Patient : Recueil des Signes Physiques »

« Inspection »

- **présence de Cicatrices**, notamment de **chirurgie cardiaque** ou **vasculaire.**
  - **circulation veineuse collatérale**, **œdème** «en pèlerine».



Cicatrice de chirurgie cardiaque





« Examen du Patient : Recueil des Signes Physiques »

« Inspection »

❑ Fréquence Respiratoire:

✔ Normale **< 15 / min** au Repos chez l'adulte.

✔ **Qualité de la Respiration (pénibilité, régularité)** : dyspnée de repos, orthopnée, **une polypnée** (fréquence respiratoire **> 20 / min**).



✔ **UnTirage sus-claviculaire,**

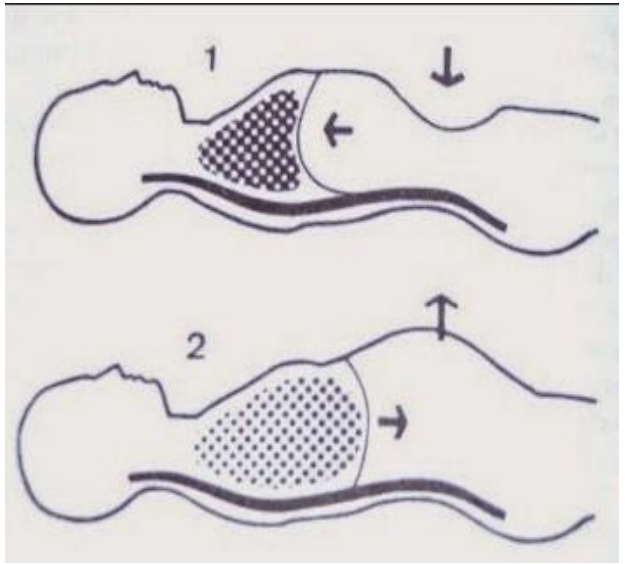
« Examen du Patient : Recueil des Signes Physiques »

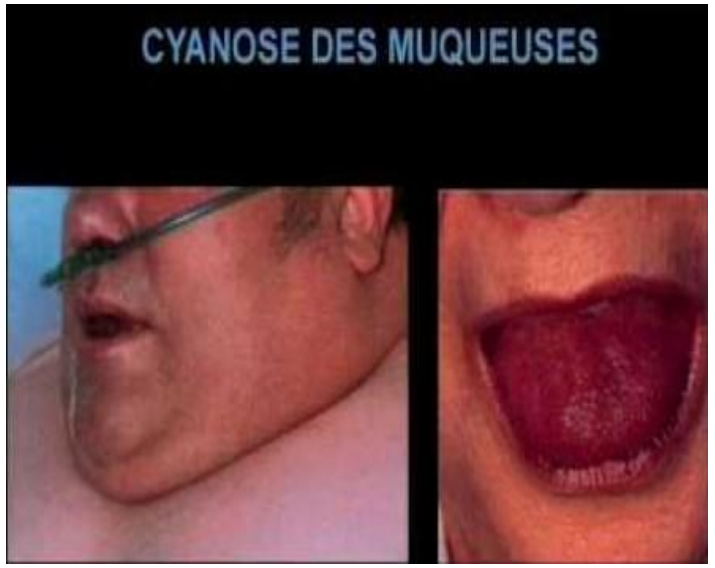
« Inspection »

- **Fréquence Respiratoire:**

Une Respiration Abdominale,

Une Cyanose voire un épuisement respiratoire avec **une Bradypnée.**







« Examen du Patient : Recueil des Signes Physiques »

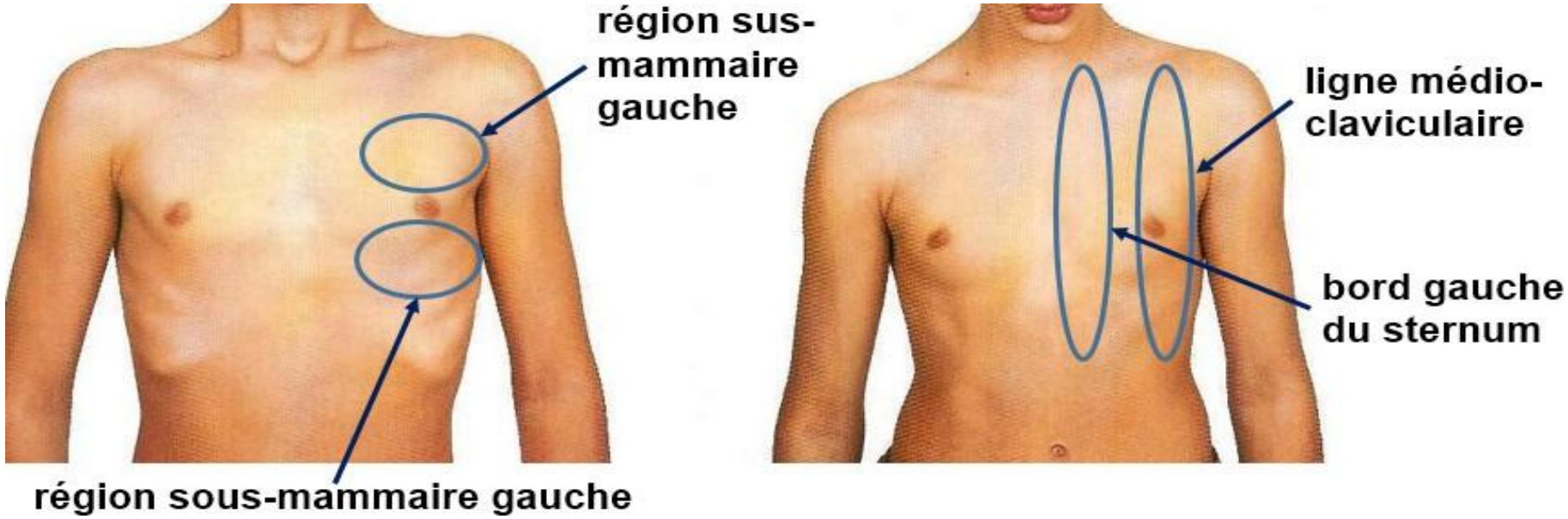
« Inspection »

- Recherche de **Pulsations Visibles** :

✔ **A gauche de la ligne médio-claviculaire**, suggèrent une Dilatation du Cœur Gauche.

✔ **Le long du bord gauche du sternum**, plaident pour une Dilatation du cœur droit.

✔ **Un soulèvement de la paroi thoracique**, synchrone du pouls, dans la **région sus-mammaire gauche**, peut témoigner d'un anévrysme pariétal du ventricule gauche.



« Examen du Patient : Recueil des Signes Physiques »

« Inspection »

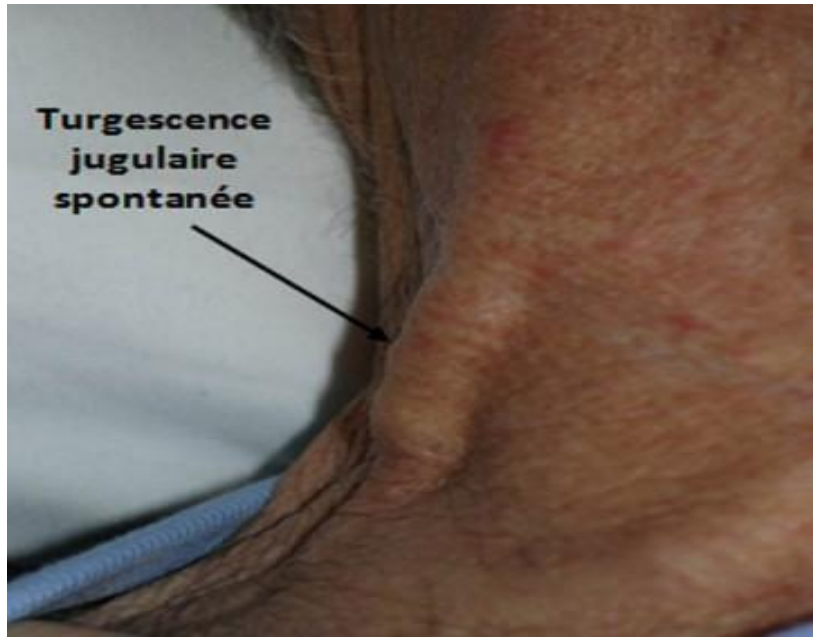
- **Signes d'insuffisance Cardiaque Droite** :

Turgescence jugulaire.

Les œdèmes des membres inférieurs d'origine cardiaque sont:

- Blancs.
- Mous.
- Bilatéraux.

- Prenant le godet et indolores mais douloureux en cas d'insuffisance cardiaque congestive.
- situés préférentiellement au niveau des chevilles et en effacent les reliefs





« Examen du Patient : Recueil des Signes Physiques »

« Palpation »

- **La palpation**, réalisée avec des mains réchauffées, permet de rechercher:

❖ **le choc de la pointe du cœur.**

❖ **les Frémissements** chez certains patients atteints de valvulopathies.

❖ Et de recueillir **des signes d'insuffisance cardiaque.**



« Examen du Patient : Recueil des Signes Physiques »

« Palpation »

« Palpation thoracique »

- Rechercher le choc de pointe.

- Il est localisé au niveau du **cinquième espace intercostal gauche.**

- au niveau de la **ligne médioclaviculaire.**

- Mieux perçu sur un sujet en décubitus latéral gauche.



« Examen du Patient : Recueil des Signes Physiques »

🕮 Variations pathologiques du choc de pointe:

✔ **Diminution ou disparition:**

- Obésité.
- Emphysème.
- Epanchement péricardique.
- insuffisance cardiaque.

✔ **Augmentation d'intensité:** Fièvre, Hyperthyroïdie.

✔ **En cas de Cardiomégalie**, le choc de pointe est dévié en bas et en dehors (a gauche).

« Examen du Patient : Recueil des Signes Physiques »

« Palpation »

- **Les Frémissements** sont la traduction tactile **des Souffles**.
- Ils ont une très grande valeur lorsqu'ils sont nets et prolongés.
- l'exemple du frémissement au cours du **Rétrécissement Mitral (RM).**



Palpation d'un frémissement ou d'une pulsation

« Examen du Patient : Recueil des Signes Physiques »

« Palpation »

- ***Signe de Harzer*** : perception des battements cardiaques au niveau de la région sous xiphoïdienne, témoin **d'une Hypertrophie du Ventricule Droit**.



- un signe inconstant observé dans **l'insuffisance Cardiaque Droite**.

« Examen du Patient : Recueil des Signes Physiques 10 »

« Palpation »

« Palpation Abdominale »

- La palpation abdominale recherche:
  - **une Hépatomégalie.**
  - et **le Reflux Hépatojugulaire.**
- Deux signes d'insuffisance Cardiaque Droite.
- **Le *Reflux Hépatojugulaire*** se recherche chez un patient en position demi-assise, à 45°.
  - Le malade respire normalement.
- La palpation effectuée au niveau de l'hypochondre droit entraîne le remplissage des veines jugulaires pendant le temps de la compression et quelques secondes après.



« Examen du Patient : Recueil des Signes Physiques »

« Percussion »

- **La percussion** est réalisée en tapant avec l'extrémité du majeur de la main droite sur les doigts de la main gauche (en général au niveau de la deuxième phalange du majeur) placée à plat sur le thorax du patient.

- Elle est peu utile pour l'examen du cœur.



« Examen du Patient : Recueil des Signes Physiques »

« Percussion »

- très utilisée au niveau ***pleuropulmonaire*** pour rechercher des épanchements liquidiens ou aérique.

- **La Percussion *Abdominale*** permet de rechercher **une Hépatomégalie** ou **une Ascite** au cours d'une insuffisance cardiaque.



« Examen du Patient : Recueil des Signes Physiques »

« Auscultation Cardiaque »

- le Temps **essentiel** de l'examen cardiaque.

- L'auscultation se fait dans une pièce silencieuse, le patient bien installé, ou le thorax facilement accessible.

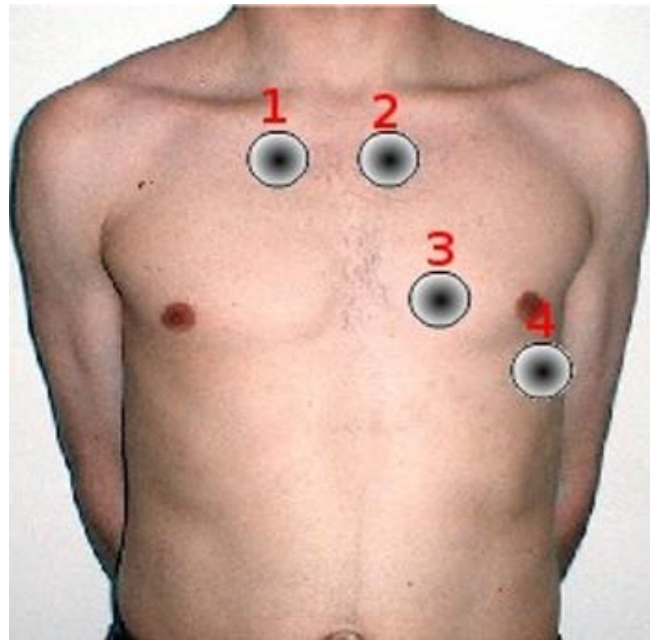
- Le **Stéthoscope Biauriculaire** doit être de bonne qualité.

- Le patient doit être ausculté en décubitus dorsal, puis latéral gauche, puis en position debout, thorax penché en avant,,,,

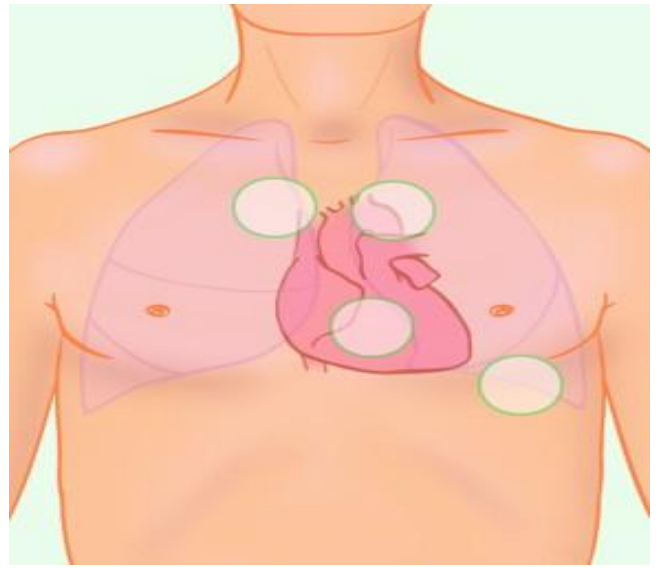
« Examen du Patient : Recueil des Signes Physiques »

« Auscultation Cardiaque »

« Les Foyers d'auscultation »



- les foyers d'auscultation ne correspondent pas à la situation anatomique des valvules correspondantes.
- **Le Foyer Aortique** : 2ième espace intercostal droit, **(Position 1)**

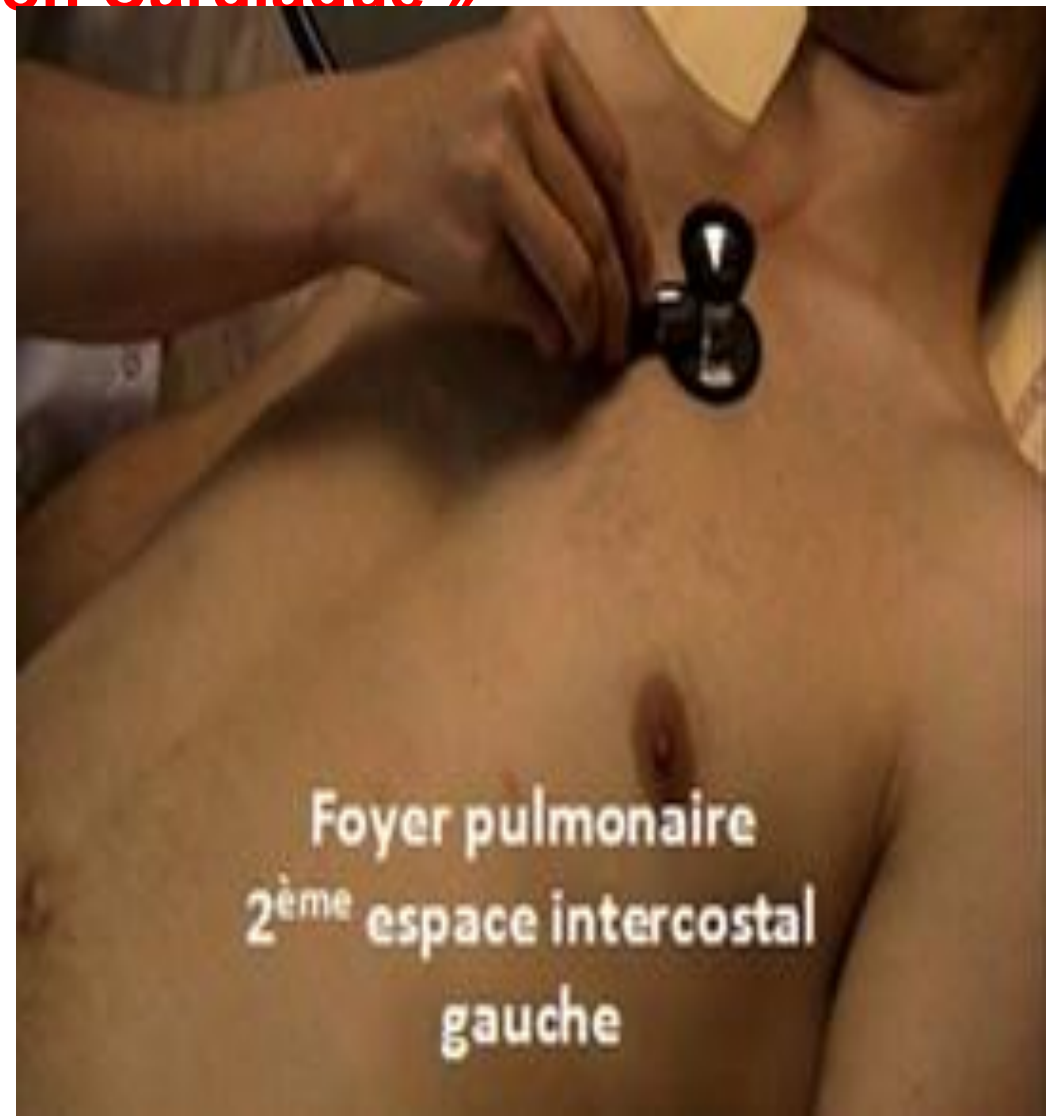


- **Le Foyer Pulmonaire :** 2ième espace intercostal gauche **(Position 2)**
- **Le Foyer Tricuspide :** 4ième espace intercostal gauche à sa partie interne (adjacente au sternum, **(Position 3)**
- **Le Foyer Mitral :** apex 5em EICG en sous

« Examen du Patient : Recueil des Signes Physiques 14 »

« Auscultation Cardiaque »





« Examen du Patient : Recueil des Signes Physiques 15 »

« Auscultation Cardiaque »





« Examen du Patient : Recueil des Signes Physiques »

« Auscultation Cardiaque »

- **Foyer Mitral:** mieux entendu en DLG (Décubitus Latéral Gauche).
- **Foyer Aortique :** mieux entendu en position assise penchée en avant.
- **Foyer pulmonaire foyer tricuspide :** mieux entendu en inspiration profonde.

- **NB**: l'auscultation ne se limite pas à ces seules régions.
- **Des données importantes** peuvent être recueillies à d'autres niveaux :

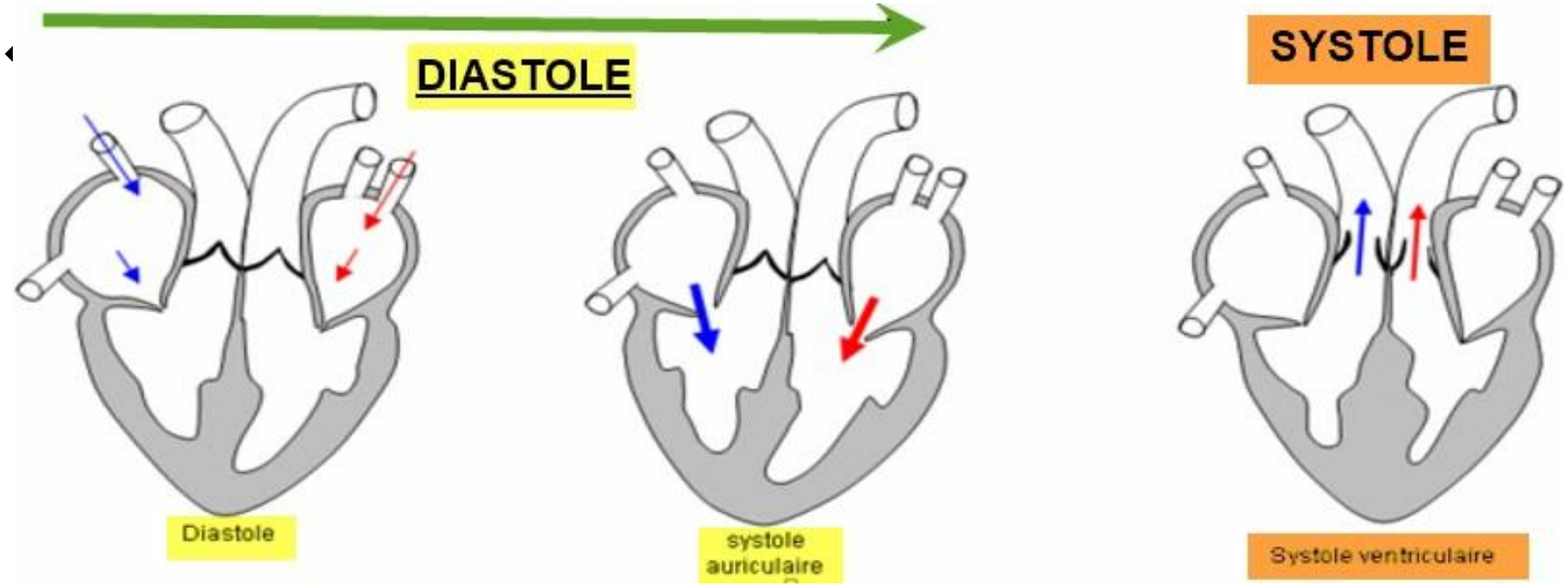
✔ les zones intermédiaires, la région para sternale droite, le cou **(propagation des souffles aortiques),** la région axillaire

(propagation des souffles mitraux),,,,,,,,,,,,

« Auscultation Cardiaque » « Auscultation Normale »

- Le régime Hémodynamique du cœur marqué par le jeu des variations de pression dans les différentes cavités, détermine les ouvertures et fermetures valvulaires.

- Ce sont **les Fermetures** qui engendrent **les 2 Bruits Normaux du cœur B1 et B2**.



« Auscultation Cardiaque » « Auscultation Normale »

- **Le Premier Bruit, ou B1:** correspond à **la Fermeture des valves auriculo- ventriculaires** mitrale (B1M) et tricuspide (B1T) lors de la contraction du myocarde **au début de la systole ventriculaire,** de tonalité grave, maximum à la pointe.

- **Le Deuxième Bruit, ou B2:** correspond à **la Fermeture des valves sigmoïdes aortique (B2A) et pulmonaire (B2P)**. Il est de tonalité plus haute que le B1, plus sec, maximum à la base.

« Auscultation Cardiaque » « Auscultation Normale »

- Le B1 marque le début de **la Systole Ventriculaire.**
- et le B2 marque le début de **la Diastole Ventriculaire.**

- **l'intervalle B1-B2** (« petit silence ») délimite **la Systole Ventriculaire.**
- et **l'intervalle B2-B1** (« grand silence ») **la Diastole Ventriculaire.**

« Auscultation Cardiaque » « Auscultation Normale »

- **En Fonction de B1 et B2**, on individualise plusieurs phases du cycle cardiaque qui serviront à la **Description des Anomalies Auscultatoires** :

✔ Protosystolique (en début de systole).

✔ Mésosystolique (en milieu de systole).

✔ Télésystolique (en fin de systole).

✔ Holosystolique (toute la durée de la systole).

✔ et de la même façon.

Protodiastolique,Mésodiastolique,Télédiastolique, Holodiastolique,

« Auscultation Cardiaque » « Auscultation Normale »

- **Dédoublement physiologique du Deuxième bruit :** Ce deuxième bruit se dédouble à l'inspiration chez le sujet normal .

Il est particulièrement audible, au foyer pulmonaire, chez l'adolescent ou l'adulte jeune.

« Auscultation Cardiaque » « Auscultation Normale »

❖ **Le B3 physiologique** Chez environ **1/3 des sujets Normaux âgés de moins de 16 ans** et exceptionnellement après 30 ans, on peut entendre au début du grand silence un troisième bruit physiologique, ou B3 très sourd,

peu intense entendu a la pointe (simule un dédoublement du B2) .

- Il correspond à **la phase de remplissage rapide initiale du ventricule gauche**.

- **Ce rythme à trois temps** disparaît en Orthostatisme.

« Auscultation Cardiaque » « Auscultation Pathologique »

- **L'Auscultation Pathologique** étudiée en détail dans les Cours

✔ « les Bruits Cardiaques ».

✔ et « les souffles Cardiaques ».

« Examen physique du Patient »

« Mesure de la Pression artérielle »

« Conditions de mesure »

- un endroit **calme**.
- le patient est allongé depuis **au moins Dix minutes.**
- un brassard tensionnel **adapté** à la morphologie du patient.
- Le brassard doit être **à la hauteur du cœur**.
- La pression artérielle est mesurée **aux deux bras.**
- en position **allongée** puis **debout.**

« Mesure de la Pression artérielle »

« Méthode de mesure »

- Le brassard tensionnel, adapté à **la circonférence du bras** du patient, est enroulé autour du bras.



- Celui-ci doit reposer sur le plan du lit.
- **Le stéthoscope** doit être appliqué en aval du brassard, au niveau de l'artère humérale.



« Mesure de la Pression artérielle »

« Méthode de mesure »

- Le brassard est gonflé rapidement jusqu'à la

disparation du pouls radial puis

est dégonflé progressivement.





« Mesure de la Pression artérielle »

« Méthode de mesure »

- La mesure de la pression artérielle repose sur

l'apparition des **Bruits de Korotkoff**, qui correspond à **la pression systolique**, puis la disparition qui traduit **la pression diastolique.**





« Mesure de la Pression artérielle »

« Méthode de mesure »

- **La Valeur Normale** chez un adulte au repos doit être **inférieure à**
  140/90 mm Hg (Normes de l'OMS Organisation Mondiale de la Santé).

MERCI